

RECURSO CÍVEL Nº 5076607-57.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ADRIANA MENEZES DE REZENDE

RECORRENTE: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

RECORRIDO: WERNER SCHMITZ (AUTOR)

TRIBUTÁRIO. IRPF. ISENÇÃO. CARDIOPATIA GRAVE. RESTITUIÇÃO DE VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS. ARTIGO 6º, INCISOS XIV E XXI DA LEI Nº 7.713/88. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. ALEGAÇÕES DO RECORRENTE DE QUE O LAUDO MÉDICO JUNTADO DEVE SER EXPEDIDO POR ÓRGÃOS PÚBLICOS E QUE AUTOR NÃO COMPROVOU DOENÇA GRAVE. DESNECESSIDADE DE LAUDO PÚBLICO. SÚMULA 598 STJ. AUTOR COMPROVOU CARDIOPATIA GRAVE. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER do recurso da parte ré e NEGAR-LHE provimento, mantendo incólume a sentença a quo. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que ora fixo em 10% sobre o valor da condenação. Intimem-se as partes e após o trânsito em julgado dê-se baixa e remetam-se os autos ao Juízo de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 26 de fevereiro de 2025.

5076607-57.2024.4.02.5101

510015510158 .V4

RECURSO CÍVEL Nº 5076607-57.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ADRIANA MENEZES DE REZENDE

RECORRENTE: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

RECORRIDO: WERNER SCHMITZ (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se recurso da União em face da sentença que julgou procedente o pedido autoral de que reconhece o direito do autor à isenção de imposto de renda sobre os proventos recebidos a título de aposentadoria, bem como a restituição dos valores indevidamente descontados de seus proventos, a título de imposto de renda, corrigidos pela SELIC, nos termos do artigo 6º, incisos XIV e XXI da Lei nº 7.713/88, em razão de doença grave (cardiopatia grave).

Em razões recursais (Evento 16), a parte ré requer que seja julgado improcedente o pedido autoral pela falta de comprovação da doença por meio de laudo médico emitido por profissional de órgão público, tendo a parte autora juntado laudo de médico particular. Afirma ainda que não houve confirmação que o autor sofre com cardiopatia grave.

Interpostas contrarrazões da parte autora (Evento 18), pugnando pela manutenção da sentença guerreada.

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

Inicialmente, convém verificar os termos da Lei 7.713/88, que estabelece a isenção para os portadores de cardiopatia grave, verbis:

Art. 6º Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por pessoas físicas:

*XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, **cardiopatia grave**, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte*

deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; **(Redação dada pela Lei nº 11.052, de 2004)** **(Vide Lei nº 13.105, de 2015)** **(Vigência)** **(Vide ADIN 6025)**

De acordo com o art. 30, *caput*, da Lei 9.250/1999, somente o laudo pericial emitido por serviço médico oficial poderia comprovar a moléstia grave. Contudo, essa exigência de laudo oficial foi afastada pelo STJ, conforme enunciado da sua Súmula nº 598:

É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.

Importante frisar que não é necessário que o contribuinte apresente os sintomas da doença, a incapacidade total ou a internação hospitalar para o deferimento ou manutenção da isenção. Basta que o indivíduo seja portador de uma das enfermidades listadas para obter o benefício fiscal, sendo irrelevante a evolução da doença. O objetivo da isenção é proporcionar melhores condições financeiras para que o paciente suporte o tratamento.

Esse também é entendimento do STJ, conforme enunciado de sua Súmula nº 627:

O contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade.

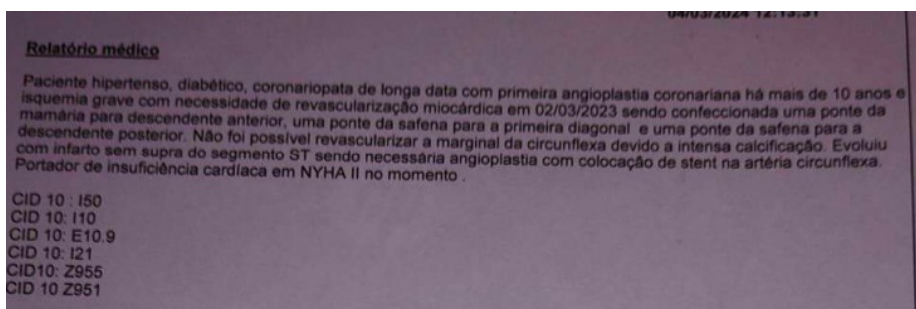
No caso, foram anexados aos autos documentos que comprovam que o autor é aposentado (Evento 1, CHEQ10), e que possui a doença de cardiopatia grave (Evento 1, EXMMED16), que é uma das elencadas no art. 6º, XIV, da Lei n.º 7.713/88.

A União aduz que a cardiopatia não seria grave.

Mas segundo a Diretriz Brasileira de Cardiologia, diz que os seguintes quadros são considerados graves na cardiopatia:

- a) cardiopatias agudas, habitualmente rápidas em sua evolução, que se tornam crônicas, caracterizadas por perda da capacidade física e funcional do coração;*
- b) as cardiopatias crônicas, quando limitam, progressivamente, a capacidade física e funcional do coração (ultrapassando os limites de eficiência dos mecanismos de compensação), não obstante o tratamento clínico e/ou cirúrgico adequado;*
- c) cardiopatias crônicas ou agudas que apresentam dependência total de suporte inotrópico farmacológico (como dobutamina, dopamina) ou mecânico (tipo Biopump, balão intra-aórtico);*
- d) cardiopatia terminal: forma de cardiopatia grave em que a expectativa de vida se encontra extremamente reduzida, geralmente não responsiva à terapia farmacológica máxima ou ao suporte hemodinâmico externo. Esses pacientes não são candidatos à terapia cirúrgica, para correção do distúrbio de base (valvopatia, cardiopatia isquêmica, cardiopatia congênita...) ou transplante cardíaco, devido à severidade do quadro clínico ou comorbidades associadas (hipertensão arterial pulmonar, disfunção renal severa, neoplasia avançada).*

No laudo médico, está registrado que o autor apresenta:



Assim, fica claro que seu quadro é grave, conforme a alínea "c" da diretriz médica, já que a cardiopatia é crônica e exige suporte mecânico (stent).

Dessa forma, comprovando a parte autora que recebe proventos de aposentadoria e é portadora de doença grave, é de se reconhecer seu direito à isenção do Imposto de Renda sobre os proventos recebidos, bem como o direito à restituição dos valores descontados indevidamente, desde o início do quadro de doença ou da data de concessão da aposentadoria, reforma ou pensão, respeitando o prazo prescricional quinquenal, conforme o art. 168 do CTN e art. 3º da Lei Complementar nº 118/2005, bem como a interpretação fixada no RE nº 566.621, julgado em repercussão geral.

Portanto, não merece prosperar o recurso da parte ré.

Desse modo, voto no sentido de **CONHECER** do recurso da parte ré e **NEGAR-LHE** provimento, mantendo incólume a sentença *a quo*. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que ora fixo em 10% sobre o valor da condenação. Intimem-se as partes e após o trânsito em julgado dê-se baixa e remetam-se os autos ao Juízo de origem.